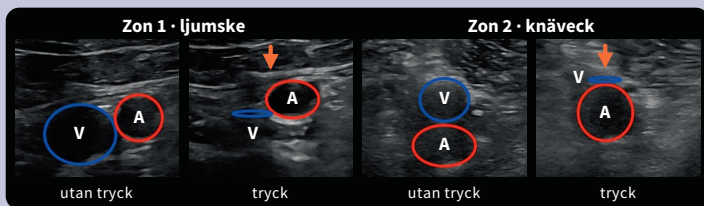


Två zoner om minst 10 cm, komprimera varje cm. Zon 1: från strax ovan saphenamynningen genom delningen i v. femoralis/profunda.

Zon 2: v. poplitea från proximala knävecket till trifurkationen.

Läge: linjär prob, tvärsnitt, markör åt patientens höger. Rygggläge med utåtroterad höft och lätt böjt knä; knävecket från baksidan, gärna sittande med benet över sängkanten.



Kompression: tryck vinkelrätt tills artären deformeras något.

Normal ven kollapsar helt: väggarna möts. Lätta på trycket om anatomin försvinner.

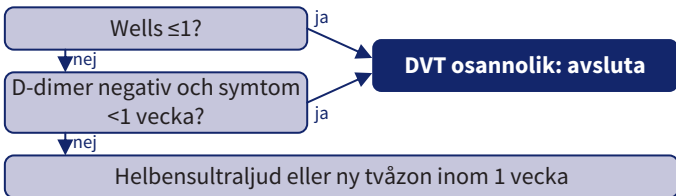
Ej komprimerbar djup ven vid adekvat tryck = DVT. Tromben syns ofta inte. Färgdoppler visar kärlen, men kompression avgör.

Fallgropar: lymfkörtel i ljumsken och Bakercysta i knävecket är avgränsade – svep ovanför och nedanför. Artär för ven: tjockare vägg, rund, pulserar. Dubblerade vener är vanliga: alla vener du ser ska gå att komprimera. Spontankontrast är inte tromb om venen komprimeras. Ytlig ven för djup: öka djupet.

Positiv · ej komprimerbar ven i zon 1 eller 2

Behandling enligt lokal DVT-rutin. Tidigare DVT i samma ben:
jämför med tidigare ultraljud.

Negativ · båda zonerna adekvat undersökta



Ej bedömbär undersökning: helbensultraljud. Försämring: ny bedömning direkt. Utesluter inte lungemboli. Bäst stöd om zon 1 förlängs till adduktorkanalen.

Flödet är inte Region Norrbottens rutin (oktober 2026).

Wells · ≤1 låg, ≥2 hög sannolikhet · **+1 per fynd:**

- Aktiv cancer
- Pares eller gips på benet
- Sängläge ≥3 d eller kirurgi <4 v
- Ömhet längs djupa vener
- Helbenssvullnad
- Vad ≥3 cm större, 10 cm nedom tuberositas
- Pittingödem, drabbade benet
- Kollateralvener, ej varicer
- Tidigare DVT

-2 Annan diagnos minst lika trolig

Hormonbehandling ingår inte i Wells: väg in. Graviditet, postpartum och svårt sjuk: särskild bedömning.

Bildkällor. Konfluerande B-linjer: Vetrugno m.fl., Ultrasound J 2020;12:39. Subpleural konsolidering: Boccatonda m.fl., J Clin Med 2023;12:1402. Pleuravätska: Walsh m.fl., Ultrasound J 2021;13:40. Fri vätska i buken: Latif m.fl., Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2023;31:25, fig. 3a–c, markerar borttagna. Samtliga CC BY 4.0, beskurna. Konsolidering: Case courtesy of Ian Bickle, Radiopaedia.org, rID: 59328, bearbetad (CC BY-NC-SA 3.0, ingår inte i licensen nedan). Hydronefros, lindrig och uttalad: Koratala m.fl., World J Nephrol 2019;8:44, fig. 10A, beskurna (CC BY-NC 4.0, ingår inte i licensen nedan). B-linjer: CC0. Gallsten, kolecystit och bukaorta: Mikael Häggström, Wikimedia Commons, CC0. Övriga bilder och illustrationer: Jesper Flodin.

Licens. POCUS-kort, Region Norrbotten, Jesper Flodin, v1.2, 2026. CC BY 4.0, creativecommons.org/licenses/by/4.0. Region Norrbottens logotyp omfattas inte av licensen. Korten är minnesstöd och ersätter inte klinisk bedömning eller lokala rutiner.